

DEFINICION

La hipertrofia adenoamigdaliana es el aumento de volumen del tejido linfático adenoideo o amigdalar.

El “Anillo linfático de Waldeyer es un acúmulo de tejido linfoide que abarca desde la rinofaringe hasta la base de la lengua. Presenta funciones inmunológicas, con mayor actividad en los primeros 6 a 12 meses de vida. Sus problemas fundamentales se relacionan con la infección y la obstrucción del tracto respiratorio superior.

Está constituido por:

- Amígdalas faríngeas
- Amígdalas peritubáricas
- Cordones faríngeos laterales
- Amígdalas palatinas

.

Adenoides

Masas linfoides de forma triangular, localizadas en la pared postero-superior del rinofarinx que están presentes al nacer y tienden a involucionar en el adulto.

Están en relación con la Trompa de Eustaquio, fosas nasales y su irrigación proviene de las ramas faríngeas de la carótida externa, maxilar interna y facial.

Están inervadas por el IX y X par.

Amígdalas

Masas linfoides ovoideas localizadas en las paredes laterales de la orofaringe.

Se encuentran adosadas a la fascia del músculo constrictor superior de la faringe, cuyo límite anterior es el músculo palatogloso, y su límite posterior es el músculo palatofaríngeo.

Inferiormente se relaciona con la amígdala lingual y su irrigación proviene de la arteria faríngea ascendente, palatina ascendente, ramas de la arteria facial y lingual. Su inervación por el IX par y ramas del nervio palatino menor

DESCRIPCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Procesos Inflamatorios Infecciosos

Adenoiditis aguda: se manifiesta con obstrucción nasal, rinorrea purulenta, fiebre y en ocasiones otitis media. Aunque puede ser difícil de diferenciar de un proceso catarral vírico agudo, su curso es más prolongado y febril.

- **Adenoiditis recurrente:** se denomina así a la concurrencia de 4 o más episodios de adenoiditis aguda en 6 meses, separados por intervalos asintomáticos. Su presentación es similar a la de la rinosinusitis aguda recurrente.

- **Adenoiditis crónica:** se manifiesta por rinorrea persistente, drenaje postnasal (“la calle del moco”, al ver la faringe), respiración maloliente, a veces acompañada de otitis media, con una duración de al menos 3 meses.

- **Amigdalitis aguda:** para comprender posteriormente las indicaciones, se considera en acuerdo con Paradise et al (3), que existe un brote agudo de faringoamigdalitis si el paciente presenta dolor de garganta y alguno de los siguientes hallazgos clínicos: Tª oral de al menos 38,3º C, adenopatía cervical dolorosa >2 cm, exudado amigdalino o cultivo positivo a estreptococo Beta-hemolítico del Grupo A.

Se debe hacer el diagnóstico diferencial entre mononucleosis infecciosa, difteria, gonorrea, sarampión, herpes simple, citomegalovirus, sífilis, VIH, hongos, TBC, Granulomatosis de Wegener, neoplasias.

- **Amigdalitis recurrente:** de acuerdo a Paradise et al (3), la amigdalitis recurrente se define en caso de 7 episodios como el descrito en 1 año, o 5 en dos años, o 3 en 3 años consecutivos.

- **Amigdalitis crónica:** es una entidad pobremente definida, basada en la clínica, que asocia dolor de garganta, halitosis, tonsilolitos, eritema peri tonsilar y/o linfadenopatía cervical dolorosa, que no cede con tratamiento médico durante al menos 3 meses

consecutivos (habiendo previamente descartado otras fuentes de infección, como amigdalitis lingual o patología sinusal)(1).

Procesos obstructivos

- **Hiperplasia adenoidea obstructiva:** se manifiesta por obstrucción nasal crónica, con rinorrea, respiración por la boca que permanece abierta, ronquido nocturno y rinolalia cerrada (“hablan por o de nariz”).

- **Hiperplasia amigdalar obstructiva:** se caracteriza porque el ronquido y la respiración forzada aparecen en el niño tanto dormido (sobre todo en decúbito supino) como despierto, pudiéndose asociar con disfagia para sólidos, enuresis nocturna, disminución del rendimiento escolar y cambios de voz (faringolalia de “patata caliente en la boca”). En estos casos el paciente puede presentar un “Síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño” (SAOS). Los criterios que se aplican al adulto no sirven para el niño y la clínica de obstrucción parcial de las vías aéreas

Superiores (manifestada por una disminución del flujo aéreo con aumento del esfuerzo respiratorio) es más frecuente en niños, pudiendo provocar hipoxemia e hipercapnia, con todas las consecuencias que se derivan. Aunque la mayor parte de casos con SAOS en niños se deben a hiperplasia Adeno-amigdalar, hay otros casos dudosos (clínica y exploración no compatibles) o en < de 2 años o que se asocian otras patologías (neurológicas, cardíacas, síndromes craneoencefálico)

Procesos neoplásicos

- Entre las tumoraciones amigdalares congénitas destacan el teratoma, hemangioma, linfangioma e higroma quístico.

La neoplasia amigdalar maligna más frecuente es el linfoma, generalmente no Hodgkin. Se manifiesta como un crecimiento rápido de una amígdala palatina, que suele asociarse con adenopatías cervicales y síntomas sistémicos, facilitando el diagnóstico de sospecha. La hiperplasia linfoide en un adolescente también debe hacernos pensar en un linfoma.

CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE HIPERTROFIA AMIGDALIANA

Esta clasificación se basa en la observación de la medida del radio comprendido entre la tonsila y el orofarinx, sin sacar la lengua:

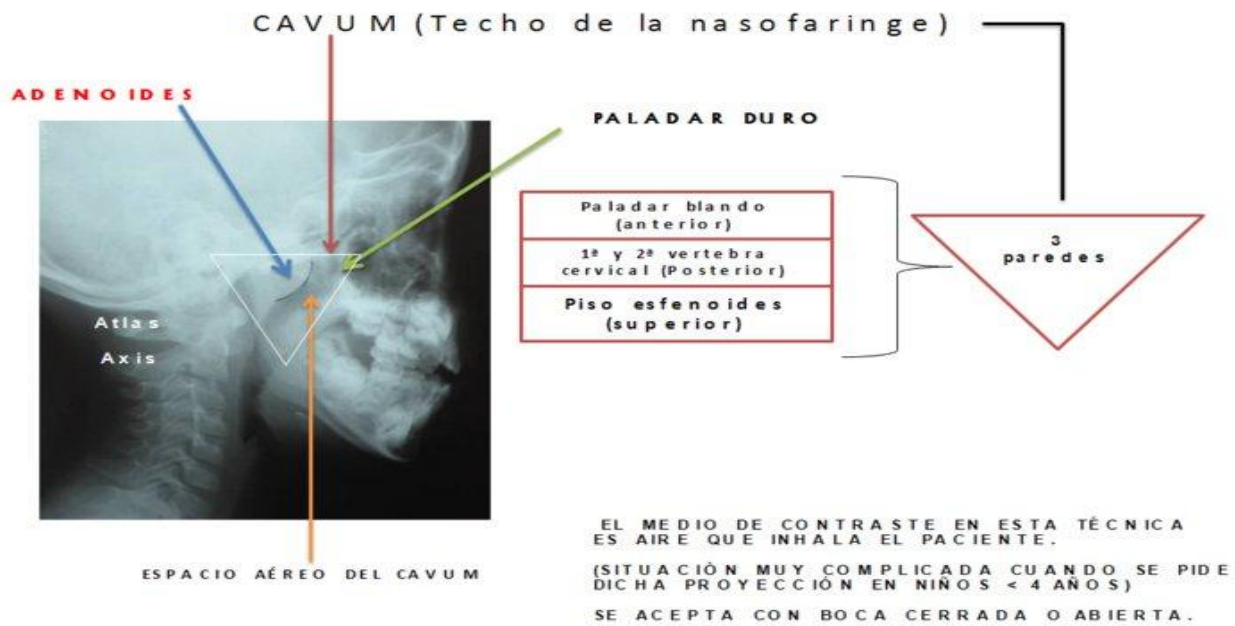
- Grado 1: Menor de 25 % de la luz faríngea, no sobrepasa pilar posterior
- Grado 2: Hipertrofia entre 25 y 50 % de la luz faríngea, hasta el pilar posterior o lo sobrepasa levemente.
- Grado 3: Hipertrofia amigdalina entre 50 a 75 % de la luz faríngea, sobrepasa pilar posterior
- Grado 4: Se contactan en la línea media (obstrucción completa)

CLASIFICACION DEL GRADO DE HIPERPLASIA ADENOIDEA

Esta medición se toma con radiografía lateral de cavum, trazando una línea que pase por el velo del paladar y otra línea paralela a esta que corre por el cuerpo del esfenoides.

- Hiperplasia No obstructiva: obstrucción <33% (de 1/3 de la columna aérea)
- Hiperplasia Semi obstructiva: Entre 33 y 66%
- Hiperplasia Obstructiva: Estrechamiento de la columna aérea en rinofaringe de más del 66% o más de 2/3

¿PORQUE SE LLAMA PROYECCIÓN DE CAVUM ?



Rx normal



Hipertrofia



CRITERIOS DE DERIVACION

- Sospecha de cáncer de amígdalas
- Obstrucción grave de la vía aérea en la orofaringe
- Amigdalitis crónica:
 - 7 episodios en el último año
 - 5 episodios en los 2 últimos años cada año
 - 3 episodios en los últimos 3 años cada año
- Hiperplasia amigdalina severa: grado III y IV
- Apnea obstructiva del sueño
- Absceso amigdalino en segunda oportunidad
- Tonsilolitiasis
- Hipertrofia adenoidea que origina respiración bucal mantenida, documentado con radiografía lateral de cavum.
- Otitis media aguda recidivante
- Otitis media secretora persistente
- Rinosinusitis
- Adenoiditis crónica: 4 episodios de adenoiditis en el semestre